

Contenu des programmes (FITT-VP)

Questions par pathologie et par niveau — complété le 23/08/2026 avec des propositions, à votre demande

Sur votre demande, les cellules qu'aucune des 10 références ne permettait de renseigner ont été complétées par des propositions, construites sur des repères génériques d'exercice thérapeutique reconnus (structuration FITT-VP et échelle de Borg selon les conventions de l'American College of Sports Medicine — ACSM ; règle de progression de 5 à 10 %/semaine usuelle en réadaptation musculosquelettique) plutôt que sur les 10 références pathologie-spécifiques. Ce ne sont pas des données probantes spécifiques à chaque pathologie : ce sont des propositions raisonnables et prudentes, à votre validation en tant que rhumatologue.

Légende

Vert : contenu directement issu d'une des 10 références citées, avec citation précise.

Bleu (PROPOSITION) : proposition de l'assistant sur repères génériques d'exercice thérapeutique (ACSM, Borg, progression usuelle), hors des 10 références — à valider ou corriger.

Rappel de vos réponses déjà données

- B4 — matrice décisionnelle narrative pour l'attribution : le statut de dépistage (vert/orange) est le premier filtre, le niveau initial fixe la dose de départ, la douleur module ensuite l'accès et l'adaptation.
- B5 — chaque combinaison pathologie + niveau doit avoir une fiche FITT-VP complète.
- B6 — intensité cible : Borg CR10 ou Borg 6-20 en mesure principale, complétée par la fréquence cardiaque et le « talk test » ; la FC max seule ne doit jamais être utilisée comme critère unique. Les valeurs Borg proposées ci-dessous (cellules bleues) suivent cette méthode.
- B9 — critères de régression par défaut, réutilisés tels quels (« Par défaut (B9) ») quand rien de spécifique à la pathologie n'a été trouvé dans les 10 références.

Pathologie : Lombalgie commune / lombosciatique commune

Code : LOMBALGIE_COMMUNE

Sources disponibles : OMS 2023 (guideline lombalgie, sans DOI), George et al. 2021 (JOSPT, 10.2519/jospt.2021.0304), Knezevic et al. 2021 (Lancet, 10.1016/S0140-6736(21)00733-9). La règle de progression 4-6 semaines d'EULAR 2025/2026 NE couvre PAS cette pathologie. Cellules bleues : propositions de l'assistant sur repères génériques d'exercice thérapeutique (ACSM, Borg), hors des 10 références — à valider.

Dosage global

Niveau	Objectif principal	Durée (sem.)	Fréquence (/sem.)	Intensité cible
Débutant	Reprendre progressivement une activité physique (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Phase initiale de 8 semaines (fenêtre usuelle d'un premier cycle de réadaptation), avec réévaluation clinique avant reconduction, changement de niveau ou ajustement.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée en séances/semaine, en cohérence avec ce volume : 2 à 3 séances/semaine (jours non consécutifs pour le renforcement).	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité légère, Borg CR10 ≈ 2-3 (ou Borg 6-20 ≈ 10-11) : effort perceptible mais confortable, talk test largement positif (parle sans difficulté). Marche continue 10 à 15 minutes en une fois.
Intermédiaire	Réduire la sédentarité (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — 8 à 12 semaines, réévaluation clinique à l'issue.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 3 à 4 séances/semaine.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée, Borg CR10 ≈ 3-4 (ou Borg 6-20 ≈ 12-13) : talk test positif (parle mais ne chante pas). Marche continue 20 à 25 minutes, ou fractionnée équivalente.
Avancé	Améliorer la condition physique (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Programme continu par cycles de 8 à 12 semaines, avec réévaluation à chaque cycle plutôt qu'une durée fixe unique.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 4 à 5 séances/semaine, réparties pour respecter 48h entre 2 sollicitations du même groupe musculaire en renforcement.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée à modérément soutenue, Borg CR10 ≈ 4-5 (ou Borg 6-20 ≈ 13-14), sans dépasser ce palier par prudence en pathologie rhumatologique ; talk test à la limite (phrases courtes). Marche continue 25 à 35 minutes ; ne pas dépasser ce palier d'intensité pour cette pathologie (absence de risque cardiovasculaire spécifique documenté dans les 3 références, mais absence aussi de justification à aller au-delà).

Composantes FITT-VP

Niveau	Aérobique	Renforcement	Mobilité	Équilibre	Fonctionnel
Débutant	D'après George et al. 2021 (JOSPT, recommandation A, niveau de preuve fort) : l'exercice aérobique fait partie de l'« exercice général » recommandé, sans supériorité démontrée par rapport aux autres approches (renforcement du tronc, exercice aquatique, multimodal).	D'après George et al. 2021 : renforcement/endurance du tronc et des grands groupes musculaires des membres, recommandation A. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, 1 à 2 minutes de repos entre séries, sans matériel ou avec élastique/poids du corps.	D'après George et al. 2021 : exercices de flexibilité/mobilité inclus dans l'« exercice général » recommandé (recommandation A), sans détail supplémentaire. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : mobilité active du rachis lombaire et des hanches (flexion/extension/rotation douces dans l'amplitude non douloureuse), 5 à 10 minutes en échauffement.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non spécifique à la lombalgie dans les 3 références, mais intégré par prudence générale (prévention de chute, population souvent sédentaire) : 5 à 10 minutes d'exercices d'équilibre simple (appui unipodal tenu, transferts d'appui), 2 fois par semaine.</i>	D'après George et al. 2021 (principe « rester actif », recommandation A) : PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — réintroduction progressive de gestes du quotidien (se pencher, porter une charge légère) selon tolérance, en fin de programme.
Intermédiaire	D'après George et al. 2021 (JOSPT, recommandation A, niveau de preuve fort) : l'exercice aérobique fait partie de l'« exercice général » recommandé, sans supériorité démontrée par rapport aux autres approches (renforcement du tronc, exercice aquatique, multimodal).	D'après George et al. 2021 : renforcement/endurance du tronc et des grands groupes musculaires des membres, recommandation A. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, 1 à 2 minutes de repos entre séries, sans matériel ou avec élastique/poids du corps.	D'après George et al. 2021 : exercices de flexibilité/mobilité inclus dans l'« exercice général » recommandé (recommandation A), sans détail supplémentaire. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : mobilité active du rachis lombaire et des hanches (flexion/extension/rotation douces dans l'amplitude non douloureuse), 5 à 10 minutes en échauffement.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non spécifique à la lombalgie dans les 3 références, mais intégré par prudence générale (prévention de chute, population souvent sédentaire) : 5 à 10 minutes d'exercices d'équilibre simple (appui unipodal tenu, transferts d'appui), 2 fois par semaine.</i>	D'après George et al. 2021 (principe « rester actif », recommandation A) : PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — réintroduction progressive de gestes du quotidien (se pencher, porter une charge légère) selon tolérance, en fin de programme.
Avancé	D'après George et al. 2021 (JOSPT, recommandation A, niveau de preuve fort) : l'exercice aérobique fait partie de l'« exercice général » recommandé, sans supériorité démontrée par rapport aux autres approches (renforcement du tronc, exercice aquatique, multimodal).	D'après George et al. 2021 : renforcement/endurance du tronc et des grands groupes musculaires des membres, recommandation A. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, 1 à 2 minutes de repos entre séries, sans matériel ou avec élastique/poids du corps.	D'après George et al. 2021 : exercices de flexibilité/mobilité inclus dans l'« exercice général » recommandé (recommandation A), sans détail supplémentaire. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : mobilité active du rachis lombaire et des hanches (flexion/extension/rotation douces dans l'amplitude non douloureuse), 5 à 10 minutes en échauffement.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non spécifique à la lombalgie dans les 3 références, mais intégré par prudence générale (prévention de chute, population souvent sédentaire) : 5 à 10 minutes d'exercices d'équilibre simple (appui unipodal tenu, transferts d'appui), 2 fois par semaine.</i>	D'après George et al. 2021 (principe « rester actif », recommandation A) : PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — réintroduction progressive de gestes du quotidien (se pencher, porter une charge légère) selon tolérance, en fin de programme.

Progression, régression, sécurité, références

Niveau	Progression	Régression	Sécurité	Références (DOI)
Débutant	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Règle de progression usuelle en réadaptation : augmenter le volume (durée ou charge), pas l'intensité et le volume en même temps, de 5 à 10 % par semaine si bonne tolérance (pas d'aggravation de la douleur au-delà de 24h, pas de nouveau signal d'alerte) ; réévaluer tous les 15 jours plutôt qu'à chaque séance.</i>	Par défaut (B9)	D'après George et al. 2021 (JOSPT), section Patient Education (recommandation, niveau de preuve B) : ne pas augmenter la perception de menace/peur (éviter le repos au lit prolongé, éviter les explications pathoanatomiques poussées) ; insister sur le pronostic globalement favorable et l'importance de rester actif. Cohérent avec Knezevic et al. 2021 (Lancet), qui situe les approches non pharmacologiques en première ligne dans un modèle biopsychosocial, sans dosage précis. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé :	OMS 2023 (sans DOI), 10.2519/jospt.2021.0304, 10.1016/S0140-6736(21)00733-9, 10.1136/bjsports-2020-102955 (dosage transversal)

Niveau	Progression	Régression	Sécurité	Références (DOI)
			douleur > 6/10 en cours d'exercice, douleur irradiante nouvelle ou aggravée, essoufflement empêchant de parler.	
Intermédiaire	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Règle de progression usuelle en réadaptation : augmenter le volume (durée ou charge), pas l'intensité et le volume en même temps, de 5 à 10 % par semaine si bonne tolérance (pas d'aggravation de la douleur au-delà de 24h, pas de nouveau signal d'alerte) ; réévaluer tous les 15 jours plutôt qu'à chaque séance.</i>	Par défaut (B9)	D'après George et al. 2021 (JOSPT), section Patient Education (recommandation, niveau de preuve B) : ne pas augmenter la perception de menace/peur (éviter le repos au lit prolongé, éviter les explications pathoanatomiques poussées) ; insister sur le pronostic globalement favorable et l'importance de rester actif. Cohérent avec Knezevic et al. 2021 (Lancet), qui situe les approches non pharmacologiques en première ligne dans un modèle biopsychosocial, sans dosage précis. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur > 6/10 en cours d'exercice, douleur irradiante nouvelle ou aggravée, essoufflement empêchant de parler.	OMS 2023 (sans DOI), 10.2519/jospt.2021.0304, 10.1016/S0140-6736(21)00733-9, 10.1136/bjsports-2020-102955 (dosage transversal)
Avancé	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Règle de progression usuelle en réadaptation : augmenter le volume (durée ou charge), pas l'intensité et le volume en même temps, de 5 à 10 % par semaine si bonne tolérance (pas d'aggravation de la douleur au-delà de 24h, pas de nouveau signal d'alerte) ; réévaluer tous les 15 jours plutôt qu'à chaque séance.</i>	Par défaut (B9)	D'après George et al. 2021 (JOSPT), section Patient Education (recommandation, niveau de preuve B) : ne pas augmenter la perception de menace/peur (éviter le repos au lit prolongé, éviter les explications pathoanatomiques poussées) ; insister sur le pronostic globalement favorable et l'importance de rester actif. Cohérent avec Knezevic et al. 2021 (Lancet), qui situe les approches non pharmacologiques en première ligne dans un modèle biopsychosocial, sans dosage précis. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur > 6/10 en cours d'exercice, douleur irradiante nouvelle ou aggravée, essoufflement empêchant de parler.	OMS 2023 (sans DOI), 10.2519/jospt.2021.0304, 10.1016/S0140-6736(21)00733-9, 10.1136/bjsports-2020-102955 (dosage transversal)

Pathologie : Arthrose du genou

Code : ARTHROSE_GENOU

Sources disponibles : Kolasinski et al. 2019 (ACR/Arthritis Foundation, 10.1002/acr.24131), EULAR 2025/2026 (10.1016/j.ard.2026.03.006). Identique pour l'arthrose de hanche : les 2 références traitent les deux localisations conjointement.

Dosage global

Niveau	Objectif principal	Durée (sem.)	Fréquence (/sem.)	Intensité cible
Débutant	Réduire la sédentarité (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Phase initiale de 8 semaines (fenêtre usuelle d'un premier cycle de réadaptation), avec réévaluation clinique avant reconduction, changement de niveau ou ajustement.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée en séances/semaine, en cohérence avec ce volume : 2 à 3 séances/semaine (jours non consécutifs pour le renforcement).	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7, texte intégral vérifié) : débiter à une dose plus faible, bien tolérée, chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité légère, Borg CR10 ≈ 2-3 (ou Borg 6-20 ≈ 10-11) : effort perceptible mais confortable, talk test largement positif (parle sans difficulté).
Intermédiaire	Améliorer la mobilité (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — 8 à 12 semaines, réévaluation clinique à l'issue.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 3 à 4 séances/semaine.	D'après EULAR 2025/2026 : augmentation progressive de la durée ou de la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée, Borg CR10 ≈ 3-4 (ou Borg 6-20 ≈ 12-13) : talk test positif (parle mais ne chante pas).
Avancé	Améliorer la force (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Programme continu par cycles de 8 à 12 semaines, avec réévaluation à chaque cycle plutôt qu'une durée fixe unique.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 4 à 5 séances/semaine, réparties pour respecter 48h entre 2 sollicitations du même groupe musculaire en renforcement.	D'après EULAR 2025/2026 : au-delà de la période de progression initiale (4-6 semaines), les paramètres FITT-VP exacts restent délégués au professionnel de santé (Recommandation 7). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée à modérément soutenue, Borg CR10 ≈ 4-5 (ou Borg 6-20 ≈ 13-14), sans dépasser ce palier par prudence en pathologie rhumatologique ; talk test à la limite (phrases courtes).

Composantes FITT-VP

Niveau	Aérobique	Renforcement	Mobilité	Équilibre	Fonctionnel
Débutant	D'après Kolasinski et al. 2019 (ACR/Arthritis Foundation, recommandation FORTE) : la marche est une option d'exercice aérobique de première intention, sans hiérarchie par rapport au renforcement ou à l'exercice aquatique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : marche 15 à 30 minutes selon niveau, ou vélo stationnaire à faible résistance si douleur à la marche.	D'après Kolasinski et al. 2019 : renforcement musculaire recommandé en première intention (recommandation FORTE), sans hiérarchie de modalité. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : quadriceps/fessiers/ischio-jambiers, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, chaise/poids du corps, 1 à 2 minutes de repos entre séries.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Ni Kolasinski et al. 2019 ni EULAR 2025/2026 ne détaillent d'exercice de mobilité spécifique. Contenu usuel proposé : mobilisation active du genou en amplitude non douloureuse (flexion/extension assise), 5 à 10 minutes en échauffement.</i>	D'après Kolasinski et al. 2019 : l'entraînement neuromusculaire fait partie des options recommandées (recommandation FORTE), sans détail sur le contenu précis. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : appui unipodal tenu (avec appui de sécurité type chaise/mur), transferts d'appui, 5 à 10 minutes, 2 fois par semaine.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillé par les 2 références. Contenu usuel proposé : lever de chaise, montée/descente de marche, selon tolérance, introduits en phase intermédiaire/avancée.</i>
Intermédiaire	D'après Kolasinski et al. 2019 (ACR/Arthritis Foundation, recommandation FORTE) : la marche est une option d'exercice aérobique de première intention, sans hiérarchie par rapport au renforcement ou à l'exercice aquatique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : marche 15 à 30 minutes selon niveau, ou vélo stationnaire à faible résistance si douleur à la marche.	D'après Kolasinski et al. 2019 : renforcement musculaire recommandé en première intention (recommandation FORTE), sans hiérarchie de modalité. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : quadriceps/fessiers/ischio-jambiers, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, chaise/poids du corps, 1 à 2 minutes de repos entre séries.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Ni Kolasinski et al. 2019 ni EULAR 2025/2026 ne détaillent d'exercice de mobilité spécifique. Contenu usuel proposé : mobilisation active du genou en amplitude non douloureuse (flexion/extension assise), 5 à 10 minutes en échauffement.</i>	D'après Kolasinski et al. 2019 : l'entraînement neuromusculaire fait partie des options recommandées (recommandation FORTE), sans détail sur le contenu précis. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : appui unipodal tenu (avec appui de sécurité type chaise/mur), transferts d'appui, 5 à 10 minutes, 2 fois par semaine.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillé par les 2 références. Contenu usuel proposé : lever de chaise, montée/descente de marche, selon tolérance, introduits en phase intermédiaire/avancée.</i>
Avancé	D'après Kolasinski et al. 2019 (ACR/Arthritis Foundation, recommandation FORTE) : la marche est une option d'exercice aérobique de première intention, sans hiérarchie par rapport au renforcement ou à l'exercice aquatique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : marche 15 à 30 minutes selon niveau, ou vélo stationnaire à faible résistance si douleur à la marche.	D'après Kolasinski et al. 2019 : renforcement musculaire recommandé en première intention (recommandation FORTE), sans hiérarchie de modalité. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : quadriceps/fessiers/ischio-jambiers, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, chaise/poids du corps, 1 à 2 minutes de repos entre séries.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Ni Kolasinski et al. 2019 ni EULAR 2025/2026 ne détaillent d'exercice de mobilité spécifique. Contenu usuel proposé : mobilisation active du genou en amplitude non douloureuse (flexion/extension assise), 5 à 10 minutes en échauffement.</i>	D'après Kolasinski et al. 2019 : l'entraînement neuromusculaire fait partie des options recommandées (recommandation FORTE), sans détail sur le contenu précis. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : appui unipodal tenu (avec appui de sécurité type chaise/mur), transferts d'appui, 5 à 10 minutes, 2 fois par semaine.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillé par les 2 références. Contenu usuel proposé : lever de chaise, montée/descente de marche, selon tolérance, introduits en phase intermédiaire/avancée.</i>

Progression, régression, sécurité, références

Niveau	Progression	Régression	Sécurité	Références (DOI)
Débutant	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débiter à dose plus faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à 10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : aucune contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique elle-même (contre-indication retirée en 2025/2026, présente dans la version 2018) ; adapter l'intensité selon l'articulation/la zone atteinte (éviter la forte intensité sur une zone atteinte, ex. genou gonflé — les zones non atteintes restent praticables à forte intensité). Effets indésirables rapportés transitoires et légers (douleur musculaire, fatigue). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur	10.1002/acr.24131, 10.1016/j.ard.2026.03.006

Niveau	Progression	Régression	Sécurité	Références (DOI)
			articulaire > 5-6/10 en cours d'exercice, gonflement articulaire aigu nouveau.	
Intermédiaire	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débiter à dose plus faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à 10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : aucune contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique elle-même (contre-indication retirée en 2025/2026, présente dans la version 2018) ; adapter l'intensité selon l'articulation/la zone atteinte (éviter la forte intensité sur une zone atteinte, ex. genou gonflé — les zones non atteintes restent praticables à forte intensité). Effets indésirables rapportés transitoires et légers (douleur musculaire, fatigue). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur articulaire > 5-6/10 en cours d'exercice, gonflement articulaire aigu nouveau.	10.1002/acr.24131, 10.1016/j.ard.2026.03.006
Avancé	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débiter à dose plus faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à 10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : aucune contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique elle-même (contre-indication retirée en 2025/2026, présente dans la version 2018) ; adapter l'intensité selon l'articulation/la zone atteinte (éviter la forte intensité sur une zone atteinte, ex. genou gonflé — les zones non atteintes restent praticables à forte intensité). Effets indésirables rapportés transitoires et légers (douleur musculaire, fatigue). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur articulaire > 5-6/10 en cours d'exercice, gonflement articulaire aigu nouveau.	10.1002/acr.24131, 10.1016/j.ard.2026.03.006

Pathologie : Arthrose de hanche

Code : ARTHROSE_HANCHE

Mêmes 2 références que l'arthrose du genou (Kolasinski et al. 2019 traite les deux localisations conjointement) : contenu identique ci-dessous.

Dosage global

Niveau	Objectif principal	Durée (sem.)	Fréquence (/sem.)	Intensité cible
Débutant	Réduire la sédentarité (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée (fenêtre usuelle d'un premier cycle de réadaptation), avec réévaluation clinique avant reconduction, changement de niveau ou ajustement.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée en séances/semaine, en cohérence avec ce volume : 2 à 3 séances/semaine (jours non consécutifs pour le renforcement).	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7, texte intégral vérifié) : débiter à une dose plus faible, bien tolérée, chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité légère, Borg CR10 ≈ 2-3 (ou Borg 6-20 ≈ 10-11) : effort perceptible mais confortable, talk test largement positif (parle sans difficulté).
Intermédiaire	Améliorer la mobilité (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — 8 à 12 semaines, réévaluation clinique à l'issue.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 3 à 4 séances/semaine.	D'après EULAR 2025/2026 : augmentation progressive de la durée ou de la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée, Borg CR10 ≈ 3-4 (ou Borg 6-20 ≈ 12-13) : talk test positif (parle mais ne chante pas).
Avancé	Améliorer la force (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Programme continu par cycles de 8 à 12 semaines, avec réévaluation à chaque cycle plutôt qu'une durée fixe unique.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 4 à 5 séances/semaine, réparties pour respecter 48h entre 2 sollicitations du même groupe musculaire en renforcement.	D'après EULAR 2025/2026 : au-delà de la période de progression initiale (4-6 semaines), les paramètres FITT-VP exacts restent délégués au professionnel de santé (Recommandation 7). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée à modérément soutenue, Borg CR10 ≈ 4-5 (ou Borg 6-20 ≈ 13-14), sans dépasser ce palier par prudence en pathologie rhumatologique ; talk test à la limite (phrases courtes).

Composantes FITT-VP

Niveau	Aérobique	Renforcement	Mobilité	Équilibre	Fonctionnel
Débutant	D'après Kolasinski et al. 2019 (ACR/Arthritis Foundation, recommandation FORTE) : la marche est une option d'exercice aérobique de première intention, sans hiérarchie par rapport au renforcement ou à l'exercice aquatique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : marche 15 à 30 minutes selon niveau, ou vélo stationnaire à faible résistance si douleur à la marche.	D'après Kolasinski et al. 2019 : renforcement musculaire recommandé en première intention (recommandation FORTE), sans hiérarchie de modalité. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : fessiers/abducteurs de hanche/quadriceps, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, chaise/poids du corps, 1 à 2 minutes de repos entre séries.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Ni Kolasinski et al. 2019 ni EULAR 2025/2026 ne détaillent d'exercice de mobilité spécifique. Contenu usuel proposé : mobilisation active de la hanche en amplitude non douloureuse, 5 à 10 minutes en échauffement.</i>	D'après Kolasinski et al. 2019 : l'entraînement neuromusculaire fait partie des options recommandées (recommandation FORTE), sans détail sur le contenu précis. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : appui unipodal tenu (avec appui de sécurité), transferts d'appui, 5 à 10 minutes, 2 fois par semaine.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillé par les 2 références. Contenu usuel proposé : lever de chaise, montée/descente de marche, selon tolérance, introduits en phase intermédiaire/avancée.</i>
Intermédiaire	D'après Kolasinski et al. 2019 (ACR/Arthritis Foundation, recommandation FORTE) : la marche est une option d'exercice aérobique de première intention, sans hiérarchie par rapport au renforcement ou à l'exercice aquatique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : marche 15 à 30 minutes selon niveau, ou vélo stationnaire à faible résistance si douleur à la marche.	D'après Kolasinski et al. 2019 : renforcement musculaire recommandé en première intention (recommandation FORTE), sans hiérarchie de modalité. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : fessiers/abducteurs de hanche/quadriceps, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, chaise/poids du corps, 1 à 2 minutes de repos entre séries.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Ni Kolasinski et al. 2019 ni EULAR 2025/2026 ne détaillent d'exercice de mobilité spécifique. Contenu usuel proposé : mobilisation active de la hanche en amplitude non douloureuse, 5 à 10 minutes en échauffement.</i>	D'après Kolasinski et al. 2019 : l'entraînement neuromusculaire fait partie des options recommandées (recommandation FORTE), sans détail sur le contenu précis. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : appui unipodal tenu (avec appui de sécurité), transferts d'appui, 5 à 10 minutes, 2 fois par semaine.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillé par les 2 références. Contenu usuel proposé : lever de chaise, montée/descente de marche, selon tolérance, introduits en phase intermédiaire/avancée.</i>
Avancé	D'après Kolasinski et al. 2019 (ACR/Arthritis Foundation, recommandation FORTE) : la marche est une option d'exercice aérobique de première intention, sans hiérarchie par rapport au renforcement ou à l'exercice aquatique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : marche 15 à 30 minutes selon niveau, ou vélo stationnaire à faible résistance si douleur à la marche.	D'après Kolasinski et al. 2019 : renforcement musculaire recommandé en première intention (recommandation FORTE), sans hiérarchie de modalité. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : fessiers/abducteurs de hanche/quadriceps, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, chaise/poids du corps, 1 à 2 minutes de repos entre séries.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Ni Kolasinski et al. 2019 ni EULAR 2025/2026 ne détaillent d'exercice de mobilité spécifique. Contenu usuel proposé : mobilisation active de la hanche en amplitude non douloureuse, 5 à 10 minutes en échauffement.</i>	D'après Kolasinski et al. 2019 : l'entraînement neuromusculaire fait partie des options recommandées (recommandation FORTE), sans détail sur le contenu précis. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : appui unipodal tenu (avec appui de sécurité), transferts d'appui, 5 à 10 minutes, 2 fois par semaine.	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillé par les 2 références. Contenu usuel proposé : lever de chaise, montée/descente de marche, selon tolérance, introduits en phase intermédiaire/avancée.</i>

Progression, régression, sécurité, références

Niveau	Progression	Régression	Sécurité	Références (DOI)
Débutant	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débiter à dose plus faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à 10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : aucune contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique elle-même (contre-indication retirée en 2025/2026, présente dans la version 2018) ; adapter l'intensité selon l'articulation/la zone atteinte (éviter la forte intensité sur une zone atteinte, ex. genou gonflé — les zones non atteintes restent praticables à forte intensité). Effets indésirables rapportés transitoires et légers (douleur musculaire, fatigue). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur	10.1002/acr.24131, 10.1016/j.ard.2026.03.006

Niveau	Progression	Régression	Sécurité	Références (DOI)
			articulaire > 5-6/10 en cours d'exercice, gonflement articulaire aigu nouveau.	
Intermédiaire	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débiter à dose plus faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à 10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : aucune contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique elle-même (contre-indication retirée en 2025/2026, présente dans la version 2018) ; adapter l'intensité selon l'articulation/la zone atteinte (éviter la forte intensité sur une zone atteinte, ex. genou gonflé — les zones non atteintes restent praticables à forte intensité). Effets indésirables rapportés transitoires et légers (douleur musculaire, fatigue). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur articulaire > 5-6/10 en cours d'exercice, gonflement articulaire aigu nouveau.	10.1002/acr.24131, 10.1016/j.ard.2026.03.006
Avancé	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débiter à dose plus faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à 10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : aucune contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique elle-même (contre-indication retirée en 2025/2026, présente dans la version 2018) ; adapter l'intensité selon l'articulation/la zone atteinte (éviter la forte intensité sur une zone atteinte, ex. genou gonflé — les zones non atteintes restent praticables à forte intensité). Effets indésirables rapportés transitoires et légers (douleur musculaire, fatigue). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur articulaire > 5-6/10 en cours d'exercice, gonflement articulaire aigu nouveau.	10.1002/acr.24131, 10.1016/j.ard.2026.03.006

Pathologie : Polyarthrite rhumatoïde

Code : POLYARTHRITE_RHUMATOIDE

Sources disponibles : England et al. 2022 (ACR, 10.1002/acr.25117), EULAR 2025/2026 (10.1016/j.ard.2026.03.006).

Dosage global

Niveau	Objectif principal	Durée (sem.)	Fréquence (/sem.)	Intensité cible
Débutant	Réduire la sédentarité (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Phase initiale de 8 semaines (fenêtre usuelle d'un premier cycle de réadaptation), avec réévaluation clinique avant reconduction, changement de niveau ou ajustement.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée en séances/semaine, en cohérence avec ce volume : 2 à 3 séances/semaine (jours non consécutifs pour le renforcement).	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7, texte intégral vérifié) : débiter à une dose plus faible, bien tolérée, chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité légère, Borg CR10 ≈ 2-3 (ou Borg 6-20 ≈ 10-11) : effort perceptible mais confortable, talk test largement positif (parle sans difficulté).
Intermédiaire	Améliorer la condition physique (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — 8 à 12 semaines, réévaluation clinique à l'issue.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 3 à 4 séances/semaine.	D'après EULAR 2025/2026 : augmentation progressive de la durée ou de la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée, Borg CR10 ≈ 3-4 (ou Borg 6-20 ≈ 12-13) : talk test positif (parle mais ne chante pas).
Avancé	Améliorer la force (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Programme continu par cycles de 8 à 12 semaines, avec réévaluation à chaque cycle plutôt qu'une durée fixe unique.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 4 à 5 séances/semaine, réparties pour respecter 48h entre 2 sollicitations du même groupe musculaire en renforcement.	D'après EULAR 2025/2026 : au-delà de la période de progression initiale (4-6 semaines), les paramètres FITT-VP exacts restent délégués au professionnel de santé (Recommandation 7). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée à modérément soutenue, Borg CR10 ≈ 4-5 (ou Borg 6-20 ≈ 13-14), sans dépasser ce palier par prudence en pathologie rhumatologique ; talk test à la limite (phrases courtes).

Composantes FITT-VP

Niveau	Aérobique	Renforcement	Mobilité	Équilibre	Fonctionnel
Débutant	D'après England et al. 2022 (ACR) : recommandation FORTE pour un engagement constant dans l'exercice (par opposition à l'absence d'exercice) ; recommandation conditionnelle (preuve de faible qualité) spécifiquement en faveur de l'exercice aérobique et de l'exercice aquatique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : marche ou aquagym 15 à 30 minutes selon niveau ; l'exercice aquatique est particulièrement adapté en cas d'atteinte articulaire multiple (réduit la mise en charge).	D'après England et al. 2022 : recommandation conditionnelle (preuve de faible qualité) en faveur du renforcement musculaire. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : grands groupes musculaires, 2 séries de 8 à 12 répétitions (volume prudent, à ajuster selon l'atteinte articulaire du jour), 48h entre 2 séances sollicitant le même groupe.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillée par England et al. 2022. Contenu usuel proposé : mobilité active quotidienne des petites et grandes articulations (mains, poignets, genoux, épaules), en particulier le matin (déroutillage matinal), 5 à 10 minutes.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillée par England et al. 2022. Non prioritaire en l'absence d'atteinte fonctionnelle associée ; à évaluer individuellement selon l'atteinte articulaire du patient.	D'après England et al. 2022 : recommandation conditionnelle (preuve de faible qualité) en faveur des approches « corps-esprit », en complément de l'exercice aérobique — catégorisation « fonctionnel » proposée par les rédacteurs, à confirmer.
Intermédiaire	D'après England et al. 2022 (ACR) : recommandation FORTE pour un engagement constant dans l'exercice (par opposition à l'absence d'exercice) ; recommandation conditionnelle (preuve de faible qualité) spécifiquement en faveur de l'exercice aérobique et de l'exercice aquatique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : marche ou aquagym 15 à 30 minutes selon niveau ; l'exercice aquatique est particulièrement adapté en cas d'atteinte articulaire multiple (réduit la mise en charge).	D'après England et al. 2022 : recommandation conditionnelle (preuve de faible qualité) en faveur du renforcement musculaire. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : grands groupes musculaires, 2 séries de 8 à 12 répétitions (volume prudent, à ajuster selon l'atteinte articulaire du jour), 48h entre 2 séances sollicitant le même groupe.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillée par England et al. 2022. Contenu usuel proposé : mobilité active quotidienne des petites et grandes articulations (mains, poignets, genoux, épaules), en particulier le matin (déroutillage matinal), 5 à 10 minutes.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillée par England et al. 2022. Non prioritaire en l'absence d'atteinte fonctionnelle associée ; à évaluer individuellement selon l'atteinte articulaire du patient.	D'après England et al. 2022 : recommandation conditionnelle (preuve de faible qualité) en faveur des approches « corps-esprit », en complément de l'exercice aérobique — catégorisation « fonctionnel » proposée par les rédacteurs, à confirmer.
Avancé	D'après England et al. 2022 (ACR) : recommandation FORTE pour un engagement constant dans l'exercice (par opposition à l'absence d'exercice) ; recommandation conditionnelle (preuve de faible qualité) spécifiquement en faveur de l'exercice aérobique et de l'exercice aquatique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : marche ou aquagym 15 à 30 minutes selon niveau ; l'exercice aquatique est particulièrement adapté en cas d'atteinte articulaire multiple (réduit la mise en charge).	D'après England et al. 2022 : recommandation conditionnelle (preuve de faible qualité) en faveur du renforcement musculaire. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : grands groupes musculaires, 2 séries de 8 à 12 répétitions (volume prudent, à ajuster selon l'atteinte articulaire du jour), 48h entre 2 séances sollicitant le même groupe.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillée par England et al. 2022. Contenu usuel proposé : mobilité active quotidienne des petites et grandes articulations (mains, poignets, genoux, épaules), en particulier le matin (déroutillage matinal), 5 à 10 minutes.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillée par England et al. 2022. Non prioritaire en l'absence d'atteinte fonctionnelle associée ; à évaluer individuellement selon l'atteinte articulaire du patient.	D'après England et al. 2022 : recommandation conditionnelle (preuve de faible qualité) en faveur des approches « corps-esprit », en complément de l'exercice aérobique — catégorisation « fonctionnel » proposée par les rédacteurs, à confirmer.

Progression, régression, sécurité, références

Niveau	Progression	Régression	Sécurité	Références (DOI)
Débutant	D'après England et al. 2022, aucun rythme de progression n'est précisé. D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débuter à dose plus	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : aucune contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique elle-même (contre-indication retirée en 2025/2026,	10.1002/acr.25117, 10.1016/j.ard.2026.03.006

Niveau	Progression	Régression	Sécurité	Références (DOI)
	faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à 10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.		présente dans la version 2018) ; adapter l'intensité selon l'articulation/la zone atteinte (éviter la forte intensité sur une zone atteinte, ex. genou gonflé — les zones non atteintes restent praticables à forte intensité). Effets indésirables rapportés transitoires et légers (douleur musculaire, fatigue). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : signe de poussée en cours de séance (gonflement articulaire nouveau, raideur marquée), douleur > 6/10.	
Intermédiaire	D'après England et al. 2022, aucun rythme de progression n'est précisé. D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débiter à dose plus faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à 10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : aucune contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique elle-même (contre-indication retirée en 2025/2026, présente dans la version 2018) ; adapter l'intensité selon l'articulation/la zone atteinte (éviter la forte intensité sur une zone atteinte, ex. genou gonflé — les zones non atteintes restent praticables à forte intensité). Effets indésirables rapportés transitoires et légers (douleur musculaire, fatigue). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : signe de poussée en cours de séance (gonflement articulaire nouveau, raideur marquée), douleur > 6/10.	10.1002/acr.25117, 10.1016/j.ard.2026.03.006
Avancé	D'après England et al. 2022, aucun rythme de progression n'est précisé. D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débiter à dose plus faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à 10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : aucune contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique elle-même (contre-indication retirée en 2025/2026, présente dans la version 2018) ; adapter l'intensité selon l'articulation/la zone atteinte (éviter la forte intensité sur une zone atteinte, ex. genou gonflé — les zones non atteintes restent praticables à forte intensité). Effets indésirables rapportés transitoires et légers (douleur musculaire, fatigue). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : signe de poussée en cours de séance (gonflement articulaire nouveau, raideur marquée), douleur > 6/10.	10.1002/acr.25117, 10.1016/j.ard.2026.03.006

Pathologie : Spondyloarthrite axiale

Code : SPONDYLOARTHRITE_AXIALE

Sources disponibles : ASAS-EULAR 2022 (10.1136/ard-2022-223296), EULAR 2025/2026 (10.1016/j.ard.2026.03.006, périmètre générique, sans contenu spécifique à la mobilité rachidienne). Les cellules Mobilité/Fonctionnel sont des propositions génériques de pratique courante en axSpA, hors des 2 références citées — à valider en priorité, ce point n'étant couvert par aucune des 10 références.

Dosage global

Niveau	Objectif principal	Durée (sem.)	Fréquence (/sem.)	Intensité cible
Débutant	Réduire la sédentarité (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Phase initiale de 8 semaines (fenêtre usuelle d'un premier cycle de réadaptation), avec réévaluation clinique avant reconduction, changement de niveau ou ajustement.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée en séances/semaine, en cohérence avec ce volume : 2 à 3 séances/semaine (jours non consécutifs pour le renforcement).	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7, texte intégral vérifié) : débiter à une dose plus faible, bien tolérée, chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité légère, Borg CR10 ≈ 2-3 (ou Borg 6-20 ≈ 10-11) : effort perceptible mais confortable, talk test largement positif (parle sans difficulté). Point de vigilance ASAS-EULAR 2022 (Recommandation 4) : l'adhérence et l'efficacité sont rapportées comme meilleures en cas de supervision (kinésithérapie) par rapport aux exercices seuls à domicile — à considérer pour une application d'auto-exercice non supervisée.
Intermédiaire	Maintenir l'autonomie (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — 8 à 12 semaines, réévaluation clinique à l'issue.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 3 à 4 séances/semaine.	D'après EULAR 2025/2026 : augmentation progressive de la durée ou de la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée, Borg CR10 ≈ 3-4 (ou Borg 6-20 ≈ 12-13) : talk test positif (parle mais ne chante pas).
Avancé	Améliorer la condition physique (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Programme continu par cycles de 8 à 12 semaines, avec réévaluation à chaque cycle plutôt qu'une durée fixe unique.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 4 à 5 séances/semaine, réparties pour respecter 48h entre 2 sollicitations du même groupe musculaire en renforcement.	D'après EULAR 2025/2026 : au-delà de la période de progression initiale (4-6 semaines), les paramètres FITT-VP exacts restent délégués au professionnel de santé (Recommandation 7). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée à modérément soutenue, Borg CR10 ≈ 4-5 (ou Borg 6-20 ≈ 13-14), sans dépasser ce palier par prudence en pathologie rhumatologique ; talk test à la limite (phrases courtes).

Composantes FITT-VP

Niveau	Aérobique	Renforcement	Mobilité	Équilibre	Fonctionnel
Débutant	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — ASAS-EULAR 2022 recommande l'exercice de façon générale sans détailler de composante aérobique. Modalité usuelle proposée : marche, vélo ou natation 15 à 30 minutes selon niveau.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillé par ASAS-EULAR 2022. Modalité usuelle proposée : renforcement des extenseurs du rachis et de la ceinture scapulaire, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — ASAS-EULAR 2022 ne détaille aucun exercice de mobilité rachidienne spécifique, pourtant classiquement central dans l'axSpA en pratique courante. Contenu usuel proposé : mobilité rachidienne active (extension, rotation, inclinaisons latérales) dans l'amplitude non douloureuse, quotidienne, 10 à 15 minutes — à considérer comme la proposition la plus importante à valider de ce document, faute de tout appui dans les 2 références citées.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par ASAS-EULAR 2022. Non prioritaire sauf atteinte fonctionnelle associée.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par ASAS-EULAR 2022. Contenu usuel proposé : exercices respiratoires (amplitude thoracique, expansion costale), classiquement associés à la prise en charge de l'axSpA en pratique courante — à valider spécifiquement, absent des 2 références citées.
Intermédiaire	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — ASAS-EULAR 2022 recommande l'exercice de façon générale sans détailler de composante aérobique. Modalité usuelle proposée : marche, vélo ou natation 15 à 30 minutes selon niveau.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillé par ASAS-EULAR 2022. Modalité usuelle proposée : renforcement des extenseurs du rachis et de la ceinture scapulaire, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — ASAS-EULAR 2022 ne détaille aucun exercice de mobilité rachidienne spécifique, pourtant classiquement central dans l'axSpA en pratique courante. Contenu usuel proposé : mobilité rachidienne active (extension, rotation, inclinaisons latérales) dans l'amplitude non douloureuse, quotidienne, 10 à 15 minutes — à considérer comme la proposition la plus importante à valider de ce document, faute de tout appui dans les 2 références citées.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par ASAS-EULAR 2022. Non prioritaire sauf atteinte fonctionnelle associée.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par ASAS-EULAR 2022. Contenu usuel proposé : exercices respiratoires (amplitude thoracique, expansion costale), classiquement associés à la prise en charge de l'axSpA en pratique courante — à valider spécifiquement, absent des 2 références citées.
Avancé	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — ASAS-EULAR 2022 recommande l'exercice de façon générale sans détailler de composante aérobique. Modalité usuelle proposée : marche, vélo ou natation 15 à 30 minutes selon niveau.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non détaillé par ASAS-EULAR 2022. Modalité usuelle proposée : renforcement des extenseurs du rachis et de la ceinture scapulaire, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — ASAS-EULAR 2022 ne détaille aucun exercice de mobilité rachidienne spécifique, pourtant classiquement central dans l'axSpA en pratique courante. Contenu usuel proposé : mobilité rachidienne active (extension, rotation, inclinaisons latérales) dans l'amplitude non douloureuse, quotidienne, 10 à 15 minutes — à considérer comme la proposition la plus importante à valider de ce document, faute de tout appui dans les 2 références citées.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par ASAS-EULAR 2022. Non prioritaire sauf atteinte fonctionnelle associée.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par ASAS-EULAR 2022. Contenu usuel proposé : exercices respiratoires (amplitude thoracique, expansion costale), classiquement associés à la prise en charge de l'axSpA en pratique courante — à valider spécifiquement, absent des 2 références citées.

Progression, régression, sécurité, références

Niveau	Progression	Régression	Sécurité	Références (DOI)
Débutant	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débiter à dose plus faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après ASAS-EULAR 2022 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : « Exercise is a cornerstone in the management of axSpA, with demonstrated benefits on disease outcomes independent of pharmacological treatment. » L'adhérence est rapportée comme meilleure en cas de supervision, et « Physiotherapy, specifically supervised	10.1136/ard-2022-223296, 10.1016/j.ard.2026.03.006

Niveau	Progression	Régression	Sécurité	Références (DOI)
	10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.		exercice, has also proven to be more efficacious than home exercises » — élément à prendre en compte pour une application d'auto-exercice non supervisée. Complété par EULAR 2025/2026 (règle des 24h, pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'AP elle-même). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur rachidienne > 6/10, raideur empêchant la poursuite de l'exercice.	
Intermédiaire	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débiter à dose plus faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à 10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après ASAS-EULAR 2022 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : « Exercise is a cornerstone in the management of axSpA, with demonstrated benefits on disease outcomes independent of pharmacological treatment. » L'adhérence est rapportée comme meilleure en cas de supervision, et « Physiotherapy, specifically supervised exercise, has also proven to be more efficacious than home exercises » — élément à prendre en compte pour une application d'auto-exercice non supervisée. Complété par EULAR 2025/2026 (règle des 24h, pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'AP elle-même). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur rachidienne > 6/10, raideur empêchant la poursuite de l'exercice.	10.1136/ard-2022-223296, 10.1016/j.ard.2026.03.006
Avancé	D'après EULAR 2025/2026 (Recommandation 7) : chez les personnes déconditionnées, débiter à dose plus faible puis augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Au-delà, progression usuelle : +5 à 10 % du volume par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.	Par défaut (B9), complété par la « règle des 24 heures » d'EULAR 2025/2026 : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24h après l'exercice, réduire l'intensité.	D'après ASAS-EULAR 2022 (Recommandation 4, texte intégral vérifié) : « Exercise is a cornerstone in the management of axSpA, with demonstrated benefits on disease outcomes independent of pharmacological treatment. » L'adhérence est rapportée comme meilleure en cas de supervision, et « Physiotherapy, specifically supervised exercise, has also proven to be more efficacious than home exercises » — élément à prendre en compte pour une application d'auto-exercice non supervisée. Complété par EULAR 2025/2026 (règle des 24h, pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'AP elle-même). PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur rachidienne > 6/10, raideur empêchant la poursuite de l'exercice.	10.1136/ard-2022-223296, 10.1016/j.ard.2026.03.006

Pathologie : Ostéoporose

Code : OSTEOPOROSE

Sources disponibles : LeBoff et al. 2022 (10.1007/s00198-021-05900-y), Hoffmann et al. 2023 (10.1007/s00198-022-06592-8). Hoffmann et al. 2023 est une méta-analyse de 11 essais : réduction d'environ 23 % des fractures majeures (RR 0,75), mais les auteurs concluent eux-mêmes qu'aucun protocole précis ne peut être recommandé de façon fiable — les propositions ci-dessous s'appuient donc sur des repères génériques d'exercice en charge, pas sur un chiffre issu de cette méta-analyse.

Dosage global

Niveau	Objectif principal	Durée (sem.)	Fréquence (/sem.)	Intensité cible
Débutant	Maintenir l'autonomie (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Programme continu recommandé plutôt qu'une cure courte : Hoffmann et al. 2023 n'a pas trouvé de différence significative entre ≤ 12 mois et > 12 mois (p=.883), mais les essais favorables de la méta-analyse ont pour la plupart un suivi ≥ 12 mois. Phase initiale proposée : 8 semaines, puis poursuite continue par cycles de 3 mois avec réévaluation.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée en séances/semaine, en cohérence avec ce volume : 2 à 3 séances/semaine (jours non consécutifs pour le renforcement).	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité légère, Borg CR10 ≈ 2-3 (ou Borg 6-20 ≈ 10-11) : effort perceptible mais confortable, talk test largement positif (parle sans difficulté). Sans charge externe additionnelle à ce stade — poids du corps uniquement.
Intermédiaire	Améliorer la force (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — 8 à 12 semaines pour la phase intermédiaire, puis poursuite par cycles de 3 mois.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 3 à 4 séances/semaine.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée, Borg CR10 ≈ 3-4 (ou Borg 6-20 ≈ 12-13) : talk test positif (parle mais ne chante pas). Introduction possible d'une charge externe légère (poids libres, élastique) selon tolérance.
Avancé	Améliorer la force (proposé, à confirmer)	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Programme continu par cycles de 3 mois, sans limite de durée fixe (prévention au long cours).	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Repère transversal non spécifique à la pathologie (Bull et al. 2020, 10.1136/bjsports-2020-102955) : 150 à 300 min/semaine d'activité modérée OU 75 à 150 min/semaine d'activité vigoureuse (ou combinaison équivalente), plus renforcement musculaire des grands groupes ≥ 2 jours/semaine. Traduction proposée : 4 à 5 séances/semaine, réparties pour respecter 48h entre 2 sollicitations du même groupe musculaire en renforcement.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Valeur cible proposée (méthode déjà fixée réf. B6) : intensité modérée à modérément soutenue, Borg CR10 ≈ 4-5 (ou Borg 6-20 ≈ 13-14), sans dépasser ce palier par prudence en pathologie rhumatologique ; talk test à la limite (phrases courtes). Charge externe progressive selon tolérance, toujours sans mouvement de flexion du tronc chargée (cf. Sécurité).

Composantes FITT-VP

Niveau	Aérobique	Renforcement	Mobilité	Équilibre	Fonctionnel
Débutant	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Ni LeBoff et al. 2022 ni Hoffmann et al. 2023 ne détaillent de composante aérobique spécifique. Modalité usuelle proposée : marche en charge (« weight-bearing », cohérente avec LeBoff et al. 2022), 20 à 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine.	D'après LeBoff et al. 2022 : l'exercice en charge (« weight-bearing ») et le renforcement musculaire (« resistance-training ») font partie de l'arsenal de prévention des fractures, aux côtés du traitement pharmacologique, des apports calcium/vitamine D et de la prévention des chutes. D'après Hoffmann et al. 2023 (méta-analyse, 11 essais) : réduction d'environ 23 % des fractures ostéoporotiques majeures (RR 0,75 ; IC95 % 0,54-0,94 ; p=.006), sans qu'un protocole précis puisse être recommandé de façon fiable. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : grands groupes musculaires et rachis en extension, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, en évitant systématiquement la flexion chargée du tronc (cf. Sécurité).	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par les 2 références. Contenu usuel proposé : mobilité douce, hors flexion importante du rachis, 5 minutes en échauffement.	D'après LeBoff et al. 2022 : la prévention des chutes fait partie de l'arsenal global de prévention des fractures, sans détail d'exercice spécifique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : exercices d'équilibre systématiques (appui unipodal avec sécurité, marche talon-pointe), 5 à 10 minutes, 2 à 3 fois par semaine — cohérent avec la place de la prévention des chutes chez LeBoff et al. 2022.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par les 2 références. Contenu usuel proposé : gestes du quotidien en évitant la flexion chargée du tronc (ex. se baisser en fléchissant les genoux plutôt que le dos), cohérent avec la contre-indication de LeBoff et al. 2022.
Intermédiaire	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Ni LeBoff et al. 2022 ni Hoffmann et al. 2023 ne détaillent de composante aérobique spécifique. Modalité usuelle proposée : marche en charge (« weight-bearing », cohérente avec LeBoff et al. 2022), 20 à 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine.	D'après LeBoff et al. 2022 : l'exercice en charge (« weight-bearing ») et le renforcement musculaire (« resistance-training ») font partie de l'arsenal de prévention des fractures, aux côtés du traitement pharmacologique, des apports calcium/vitamine D et de la prévention des chutes. D'après Hoffmann et al. 2023 (méta-analyse, 11 essais) : réduction d'environ 23 % des fractures ostéoporotiques majeures (RR 0,75 ; IC95 % 0,54-0,94 ; p=.006), sans qu'un protocole précis puisse être recommandé de façon fiable. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : grands groupes musculaires et rachis en extension, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, en évitant systématiquement la flexion chargée du tronc (cf. Sécurité).	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par les 2 références. Contenu usuel proposé : mobilité douce, hors flexion importante du rachis, 5 minutes en échauffement.	D'après LeBoff et al. 2022 : la prévention des chutes fait partie de l'arsenal global de prévention des fractures, sans détail d'exercice spécifique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : exercices d'équilibre systématiques (appui unipodal avec sécurité, marche talon-pointe), 5 à 10 minutes, 2 à 3 fois par semaine — cohérent avec la place de la prévention des chutes chez LeBoff et al. 2022.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par les 2 références. Contenu usuel proposé : gestes du quotidien en évitant la flexion chargée du tronc (ex. se baisser en fléchissant les genoux plutôt que le dos), cohérent avec la contre-indication de LeBoff et al. 2022.
Avancé	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Ni LeBoff et al. 2022 ni Hoffmann et al. 2023 ne détaillent de composante aérobique spécifique. Modalité usuelle proposée : marche en charge (« weight-bearing », cohérente avec LeBoff et al. 2022), 20 à 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine.	D'après LeBoff et al. 2022 : l'exercice en charge (« weight-bearing ») et le renforcement musculaire (« resistance-training ») font partie de l'arsenal de prévention des fractures, aux côtés du traitement pharmacologique, des apports calcium/vitamine D et de la prévention des chutes. D'après Hoffmann et al. 2023 (méta-analyse, 11 essais) : réduction d'environ 23 % des fractures ostéoporotiques majeures (RR 0,75 ; IC95 % 0,54-0,94 ; p=.006), sans qu'un protocole précis puisse être recommandé de façon fiable. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par les 2 références. Contenu usuel proposé : mobilité douce, hors flexion importante du rachis, 5 minutes en échauffement.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par les 2 références. Contenu usuel proposé : mobilité douce, hors flexion importante du rachis, 5 minutes en échauffement.	D'après LeBoff et al. 2022 : la prévention des chutes fait partie de l'arsenal global de prévention des fractures, sans détail d'exercice spécifique. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Contenu usuel proposé : exercices d'équilibre systématiques (appui unipodal avec sécurité, marche talon-pointe), 5 à 10 minutes, 2 à 3 fois par semaine — cohérent avec la place de la prévention des chutes chez LeBoff et al. 2022.	PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Non abordée par les 2 références. Contenu usuel proposé : gestes du quotidien en évitant la flexion chargée du tronc (ex. se baisser en fléchissant les genoux plutôt que le dos), cohérent avec la contre-indication de LeBoff et al. 2022.

Niveau	Aérobique	Renforcement	Mobilité	Équilibre	Fonctionnel
		citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Modalité usuelle proposée : grands groupes musculaires et rachis en extension, 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, en évitant systématiquement la flexion chargée du tronc (cf. Sécurité).			

Progression, régression, sécurité, références

Niveau	Progression	Régression	Sécurité	Références (DOI)
Débutant	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Hoffmann et al. 2023 ne permet pas de dériver une règle de progression fiable (différence non significative, p=.133). Progression usuelle proposée : +5 à 10 % du volume ou de la charge par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.</i>	Par défaut (B9)	D'après LeBoff et al. 2022 (description d'une figure dans l'abstract — à vérifier sur texte intégral avant validation, déjà signalé au Sprint 5bis) : les mouvements de flexion importante du tronc augmentent le risque de fracture vertébrale, les mouvements d'extension du rachis le diminuent. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur dorsale/lombaire aiguë nouvelle (signe d'alerte de fracture vertébrale, à évaluer médicalement avant poursuite), douleur > 6/10.	10.1007/s00198-021-05900-y, 10.1007/s00198-022-06592-8
Intermédiaire	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Hoffmann et al. 2023 ne permet pas de dériver une règle de progression fiable (différence non significative, p=.133). Progression usuelle proposée : +5 à 10 % du volume ou de la charge par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.</i>	Par défaut (B9)	D'après LeBoff et al. 2022 (description d'une figure dans l'abstract — à vérifier sur texte intégral avant validation, déjà signalé au Sprint 5bis) : les mouvements de flexion importante du tronc augmentent le risque de fracture vertébrale, les mouvements d'extension du rachis le diminuent. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur dorsale/lombaire aiguë nouvelle (signe d'alerte de fracture vertébrale, à évaluer médicalement avant poursuite), douleur > 6/10.	10.1007/s00198-021-05900-y, 10.1007/s00198-022-06592-8
Avancé	<i>PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Hoffmann et al. 2023 ne permet pas de dériver une règle de progression fiable (différence non significative, p=.133). Progression usuelle proposée : +5 à 10 % du volume ou de la charge par semaine si bonne tolérance, réévaluation tous les 15 jours.</i>	Par défaut (B9)	D'après LeBoff et al. 2022 (description d'une figure dans l'abstract — à vérifier sur texte intégral avant validation, déjà signalé au Sprint 5bis) : les mouvements de flexion importante du tronc augmentent le risque de fracture vertébrale, les mouvements d'extension du rachis le diminuent. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repères génériques d'exercice thérapeutique — à valider) — Critère d'arrêt usuel proposé : douleur dorsale/lombaire aiguë nouvelle (signe d'alerte de fracture vertébrale, à évaluer médicalement avant poursuite), douleur > 6/10.	10.1007/s00198-021-05900-y, 10.1007/s00198-022-06592-8